

Bóng Có Thể Điều Chỉnh ACT (cho Phụ Nữ)

Thông tin cho bệnh nhân · Hai bóng có thể điều chỉnh hỗ trợ niệu đạo, giảm tiểu không kiểm soát khi gắng sức

WARWIKI

ACT (**Liệu pháp kiểm soát tiểu có thể điều chỉnh**) là một thiết bị cấy ghép nhỏ, **có thể điều chỉnh** dành cho phụ nữ bị **tiểu không kiểm soát khi gắng sức** — rò rỉ khi ho, cười, nâng vật nặng, hoặc tập thể dục. Hai bóng silicone nhỏ được đặt hai bên niệu đạo, gần cổ bàng quang, để nâng đỡ nhẹ nhàng và cải thiện khả năng kiểm soát. Giống như phiên bản nam (ProACT), các bóng có thể được **điều chỉnh tại phòng khám** sau phẫu thuật.

Cơ chế hoạt động

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức xảy ra khi lực nâng đỡ và áp lực đóng của niệu đạo yếu. Hai bóng tạo thêm lực nâng nhẹ, có thể điều chỉnh ở hai bên niệu đạo để giúp niệu đạo đóng kín khi gắng sức — **không** bóp chặt hoàn toàn. Mỗi bóng kết nối với một **cổng tiêm** nhỏ dưới da môi âm hộ, dùng để bơm hoặc rút nước muối điều chỉnh.

Thiết bị này có phù hợp với tôi không?

- Là lựa chọn cho **tiểu không kiểm soát khi gắng sức**, thường được cân nhắc khi phẫu thuật kiểm soát tiểu trước đó chưa hiệu quả hoặc cơ thắt yếu (ISD)
- Phù hợp nếu bạn muốn một phương án ít xâm lấn, **có thể điều chỉnh và tháo ra được**
- **Tình trạng sẵn có theo từng quốc gia** — thiết bị này được sử dụng tại các trung tâm chuyên khoa và không có ở mọi nơi; hỏi bác sĩ xem có thể thực hiện tại nơi bạn đang điều trị không
- Ít phù hợp hơn với tiểu không kiểm soát do **sa tạng chậu** hoặc **bàng quang tăng hoạt**

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rò rỉ nước tiểu khi ho, cười, nâng vật nặng, hoặc tập thể dục.

Cổ bàng quang

Nơi bàng quang nối với niệu đạo (ống thoát nước tiểu).

Bóng

Bóng silicone nhỏ tạo lực nâng đỡ nhẹ, có thể điều chỉnh.

Cổng tiêm

Van nhỏ dưới da môi âm hộ dùng để điều chỉnh lượng nước trong bóng.

Hiệu chỉnh

Điều chỉnh lượng dịch trong bóng qua nhiều lần tái khám.

ISD

Thiếu hụt cơ thắt niệu đạo — cơ đóng niệu đạo bị yếu.

CÓ ĐAU KHÔNG? Bóng được đặt trong một **ca phẫu thuật ngắn** dưới gây mê (toàn thân, tùy sống, hoặc gây tê tại chỗ kết hợp an thần), thường thực hiện ngoại trú qua các vết chích nhỏ gần cửa âm đạo — không cần rạch lớn. Bạn có thể cảm thấy đau nhẹ và sưng vài ngày. Các lần điều chỉnh tại phòng khám sau đó nhanh chóng và chỉ dùng kim nhỏ tại cổng tiêm.

Cách thực hiện

- 1 Dưới gây mê, bác sĩ dùng **X-quang hoặc siêu âm** định hướng để đặt một bóng ở **mỗi bên** niệu đạo gần cổ bàng quang qua các vết chích nhỏ cạnh cửa âm đạo.
- 2 Ống nối được luồn đến **hai cổng tiêm** dưới da môi âm hộ.
- 3 Các bóng ban đầu gần như rỗng và để yên trong thời gian lành thương.

Điều chỉnh thiết bị

- Vài tuần sau, nhóm chăm sóc sẽ bơm thêm một ít dịch qua cổng tiêm ở môi âm hộ **tại phòng khám** — chỉ một mũi kim nhỏ, không cần phẫu thuật.
- Lặp lại qua nhiều lần tái khám cho đến khi bạn kiểm soát tốt **mà không khó đi tiểu**.
- Có thể tăng hoặc giảm bất cứ lúc nào; toàn bộ thiết bị có thể **tháo ra** nếu cần.

Sau khi

- Đau nhẹ, sưng, hoặc bầm vài ngày; tránh nâng vật nặng và hoạt động mạnh trong thời gian ngắn.
- Tình trạng rò rỉ cải thiện **dần dần** khi bóng được điều chỉnh — không phải ngay lập tức.
- Thông báo cho bác sĩ hoặc kỹ thuật viên hình ảnh trong tương lai rằng bạn có thiết bị cấy ghép này.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Khó đi tiểu** hoặc không tiểu được (bóng có thể quá căng, hoặc do sưng)
- Sốt, đau tăng, đỏ, hoặc chảy dịch tại vết mổ (có thể nhiễm trùng)
- Khó chịu mới ở âm đạo, dịch tiết bất thường, hoặc tiểu ra máu (có thể thiết bị bị lòi)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. ACT dùng hai bóng có thể điều chỉnh để nâng đỡ niệu đạo, giảm tiểu không kiểm soát khi gắng sức — ít xâm lấn và có thể tháo ra.
2. Thiết bị được đặt qua các vết chích nhỏ, sau đó điều chỉnh tại phòng khám qua nhiều lần tái khám qua cổng tiêm ở môi âm hộ.
3. Thường dùng cho tiểu không kiểm soát tái phát hoặc cơ thất yếu; tình trạng sẵn có theo quốc gia — gọi ngay nếu bạn không tiểu được hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.